

Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Gründen für Krankenhausaufenthalte. Im Jahr 2023 wurden 290.327 stationäre Behandlungen aufgrund eines Schlaganfalls (ICD-10: I60–I64 ohne I62; zur Definition s. 2.2) registriert [15]. Eine frühzeitige Versorgung in spezialisierten Stroke Units im Krankenhaus oder einer Mobilen Stroke Unit kann die Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden in den ersten drei Monaten nach einem Schlaganfall signifikant senken [16, 17]. Langzeitfolgen eines Schlaganfalls können zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität führen. Ein Großteil der Betroffenen benötigt eine intensive Rehabilitation, die häufig über Monate andauert und interdisziplinäre Ansätze erfordert [17]. Einige Betroffene verlassen die Rehabilitation mit relevanten körperlichen und kognitiven Defiziten und sind zum Teil dauerhaft auf Pflege angewiesen, was erhebliche psychosoziale und finanzielle Belastungen für sie und ihre Angehörigen sowie ökonomische Folgen für das Gesundheitssystem bedeutet [18, 19].

In den letzten 25 Jahren wurde ein Rückgang der Schlag-

gemein medizinischen Maßnahmen (OPS) und (iii) Arzneimittelverordnungen, die über die Pharmazentralnummer (PZN) der Klassifikation nach der Anatomisch-Therapeutisch-Chemischen (ATC) Systematik zugeordnet werden können [29].

Die zugrundeliegende Methodik zur Ermittlung von Prävalenzen auf Basis von GKV-Routinedaten besteht aus drei Schritten: erstens der Festlegung des Prävalenzkonzepts in der Versichertengrundgesamtheit (siehe 2.1), zweitens der Entwicklung der Falldefinition zur Ermittlung von erkrankten Personen (Aufgreifkriterien) (siehe 2.2) und drittens einer alters-, geschlechts- und morbiditätsadjustierenden Hochrechnung der Prävalenzen auf die Bevölkerung unter Anwendung regressionsanalytischer Verfahren, sodass Aussagen für alle Einwohnerinnen und Einwohner in den Regionen Deutschlands getroffen werden können (siehe 2.3).

2.1 Versichertengrundgesamtheit und Prävalenzkonzept der 10-Jahres-Prävalenz von Schlaganfall

Health Monit. 2025;10(3):e13412. doi: 10.25646/13412

Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Gründen für Krankenhausaufenthalte. Im Jahr 2023 wurden 290.327 stationäre Behandlungen aufgrund eines Schlaganfalls (ICD-10: I60-I64 ohne I62; zur Definition s. 2.2) registriert [15]. Eine frühzeitige Versorgung in spezialisierten Stroke Units im Krankenhaus oder einer Mobilen Stroke Unit kann die Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden in den ersten drei Monaten nach einem Schlaganfall signifikant senken [16, 17]. Langzeitfolgen eines Schlaganfalls können zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität führen. Ein Großteil der Betroffenen benötigt eine intensive Rehabilitation, die häufig über Monate andauert und interdisziplinäre Ansätze erfordert [17]. Einige Betroffene verlassen die Rehabilitation mit relevanten körperlichen und kognitiven Defiziten und sind zum Teil dauerhaft auf Pflege angewiesen, was erhebliche psychosoziale und finanzielle Belastungen für sie und ihre Angehörigen sowie ökonomische Folgen für das Gesundheitssystem bedeutet [18, 19].

In den letzten 25 Jahren wurde ein Rückgang der Schlaganfall-Sterblichkeit beobachtet [14, 20, 21], der auf Fortschritte in der Akutversorgung zurück geht und damit auf Verbesserungen der Überlebensraten vor allem beim ischämischen Schlaganfall [2023]. Dieser Trendabfall verlangsamte sich jedoch im letzten Jahrzehnt. Gründe für die Trendabflachung in der Schlaganfall-Sterblichkeit können in einem Anstieg von Risikofaktoren wie Adipositas und Diabetes liegen [20, 2427]. Auf Basis dieser Entwicklung in Kombination mit dem demografischen Wandel der Bevölkerung wird ein Anstieg der Schlaganfall-Sterbefälle in den kommenden Jahren prognostiziert [20]. In den Jahren zwischen 2003 und 2014 hat die Lebenszeitprävalenz für Schlaganfall bei Erwachsenen um über einen Prozentpunkt von 1,9% auf 3,3% statistisch bedeutsam zugenommen. Regionalisierte Ergebnisse stehen dabei bislang jedoch nur für fünf größere Regionen in Deutschland zur Verfügung [28].